



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : هدي محمد احمد علي

العنوان : +++

الحي / المدينة : مصر القديمة

المحافظة : القاهرة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 24-09-2026

رقم التليفون : 01030457421

رقم البطاقة : 26009200102288

العمر (تاريخ الميلاد) : 20-09-1960 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)

المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الأبحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان

الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----

التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
جهة العلاج : -----
ملاحظات : -----

قسم : -----
نفقات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: هدي محمد احمد علي National ID: 26009200102288	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

هـدى
محمد احمد عني

م ٢٤ ب ٢٤ مسكن عين الصيرة
مصر القديمة - القاهرة

٢٦٠٠٩٢٠٠١٠٢٢٨٨

LM6592281

٢٠٢٥/١١ ٢٦٠٠٩٢٠٠١٠٢٢٨٨

ربة منزل
أفنى
مسلمة
أرملة

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٢/١١/٢٥

مكتوب عادل

DMS

٤١٤١٤٠٠٤٤

* زوجه

Patient Name : الأستاذ / هادي محمد احمد
Patient No. : 26009200102288
Path No. : 2830/23
Sex : Female
Age : 63 Y
Refferreing Doc :
Request No. : 13001469
Request Date : 26/08/2023
Verification Date : 25/09/2023
Financial Category : مبادره - اورام دار السلام
Department : Out Patient
Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:
Right breast lesion.

Nature of the specimen:
Right wide local excision specimen , collected at 26/8/23.

Gross Examination:

Right wide local excision specimen measured 9x6x2.5 cm with covering skin ellipse measured 4x2 cm

• Tumor extent

o Number: An ill defined firm greyish white mass

o Size: 1.9x1.9 cm

o Skin involvement: Free grossly

• Distance from margins: 0.2 cm from deep margin (least margin)

-Extra medial margin: Fibrofatty tissue 4x3cm, cut section was grey white and rubbery

-Extra superior margin: Fibrofatty tissue 2x2cm, cut section was grey white and rubbery

-Extra inferior margin: Fibrofatty tissue 3x3cm cut section was grey white and rubbery

-Extra-extra medial margin: Fibrofatty tissue 3x2cm, cut section was grey white and rubbery

-Extra-extra superior margin: Fibrofatty tissue 1.5x1cm, cut section was grey white and rubbery

-Extra-extra inferior margin: Fibrofatty tissue 3x3cm cut section was grey white and rubbery

• Frozen section:

-Medial , superior , inferior , extraextra medial , extra extra superior , and extra extra inferior margins, all show DCIS.

-Free other margins

Microscopic examination:

• Histological type: Invasive duct carcinoma

• Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)

Verified by :



[[DOCTYPE:PATHOLOGY REPORT]]



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

1- Name: د. محمد أحمد علي

Sex:

3- Medical number:

Female

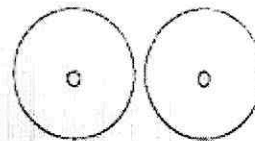
83151198

Old Med :

2528/2023

2-ID number: 26009200102288

Patient Age: 63 Y



Family history

Phone

BMI

REASON OF MDT POST OPERATIVE

marital status

MARRIED

NRS Score

01030457421

GROUP

C

Date of MDT

2023-10-02 ☐

Co morbidity

HTN,
AMenopausal
status

POSTMENOPAUSAL

Clinical data

Breast Imaging :

RT UOQ PARENCHYMAL DISTORTION REACHING NIPPLE

Mets Workup :

BX:

IDC

ER:

PR:

Her 2 Neu :

SISH :

Ki67 :

II focal DCIS

T

X

N

0

M

0

Sonomammography

PATIENT HISTORY

IDC COMPONENT AFTER WLE FOR ATYPICAL HYPERPLASIA
(REVEALED POSITIVE MARGIN AND EXTRA MARGIN)
FOR ER, PR , HER2 ON INVASIVE COMPONENT

MDT OUTCOME & PLAN

RT COMPLETION MASTECTOMY AND slnB

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

2023/10/2

RADIOLOGY

SURGERY

PATHOLOGY

Psychiatric

Nutrition

Patient Name : الأستاذة / هدي محمد احمد	Request No. : 13000577
Patient No. : 26009200102288	Request Date : 05/06/2023
Path No. : 1766/23	Verification Date : 25/06/2023
Sex : Female	Financial Category : أورام دار السلام - مبادره
Age : 63 Y	Department : Out Patient
Referring Doc. :	IHC No. :
	Registered by : Ali mostafa

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data:

Right breast lesion

Nature of the specimen:

Tru cut biopsy , taken at 5/6/2023 , 12:00 pm

Gross Examination:

Multiple fragmented greyish white tissue cores up to 0.5x0.5 cm , totally submitted

Microscopic examination:

A papillary lesion formed of branching complex papillae having branching fibro-vascular connective tissue core covered by layers of cuboidal cells with focal atypia.

-IPT:

P63 and Calponin: Positive in the peripheral aspects of the lesion.

Diagnosis:

Right breast lesion; tru cut biopsy:

-Atypical papillary lesion for excisional biopsy

Prof. Gamal Abdelatty

Dr. Marwa Mahmoud

Dr. Menna Nabil

تحليل

د. محمد عبد الله

25/6/23

Verified by :

dr.esraa magdy

Printing Date : 10/07/2023 10:31:52

Page 1 of 1

Printed By : .marwa mohamed youss

Patient Name: Hoda Mohamed Ahmed Ali	Date : 04/06/2023
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 62 Year(s)
Medical ID: 1679	Pat. ID: 38578

**FULL FIELD DIGITAL MAMMOGRAPHY AND
COMPLEMENTARY ULTRASOUND**

INDICATION:

- Nipple bloody discharge.

TECHNIQUE:

- CC and MLO view.
- Complementary ultrasound

REPORT:

Right Breast:

- Scattered fibroglandular densities (ACR B).
- UOQ focal asymmetrical density covering an area measures 3.5 x 9 cm corresponding by U/S focal glandular condensation with dilated ducts extending to nipple , focal ductal dilatation is noted at 10 o'clock measures 0.8 x 1.4 cm about 1.7 cm from the nipple show echogenic content.
- Normal skin thickness and contour.
- Normal nipple areola complex.
- Nonspecific axillary lymph nodes.

Left Breast:

- Scattered fibroglandular densities (ACR B).
- No spiculated masses or suspicious microcalcifications.
- This was confirmed by Complementary Ultrasound which showed no suspicious solid or cystic mass lesions.
- Normal skin thickness and contour.
- Normal nipple areola complex.
- Nonspecific axillary lymph nodes.

OPINION:

- Right breast UOQ focal asymmetrical density as described with bloody nipple discharge (BIRADS 4 a) for histopathological assessment.
- Normal left breast study (BIRADS1).

Signature Dr. Aya Deabes



Patient Name: Mrs/Hoda Mohamed

Date: 14.08.2023

Ultrasounded Guided Stereotactic Wire localization:

Clinical summary: RT breast paraaoreolar pathologically proved papillary lesion . two lesions are noted at 10 (area of altered signal)&9 oclock (intraductal lesion) two wire were used to localized each lesion ,in-between the two lesions there were dilated ducts(practicing was done) .

Technique:

Under complete sterile conditions, 3ml of local anaesthetic were administered at site of concern before insertion of each wire in the RT breast.

Wire one 21G wire (upper) was used to localize area of altered parenchyma with indistinct margin , about 7cm from nipple and at 9 o'clock direction and skin marking was done over the lesion

From entry side to the lesion 4.5cm

From the lesion to the skin about 1.68cm

From the skin to entry side about 4.2cm .

Wire two 21G wire (lower) was used to localize intraductal lesion , about 5cm from nipple and at 9 o'clock direction and skin marking was done over the lesion.

From entry side to the lesion 4.7cm

From the lesion to the skin about 1.46cm

From the skin to entry side about 4.6cm .